

**רמב"ם**

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

תאריך פרסום; 1.8.2017 תאריך עדכון;	תחום הנוהל: רפואי סיעודי	
	שם הנוהל; לידה טבעית	
נספחים: 1. התוויות נגד לניהול לידה טבעית 2. התוויות לשינוי גישת ניהול לידה טבעית 3. חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 4. טופס בקשה והסכמה ללידה טבעית 5. התוויות להעברת ילוד מידית למחלקת ילודים	מאשר הנוהל: פרופ' זאב ויינר מנהל מערך נשים ויולדות על החתום: פרופ' זאב ויינר	כותב הנוהל: גומר בן משה לאה טטרו יעל מוזס
תפוצה: - מנהל אגף נשים יולדות - מנהל ט. נמרץ פגים וילודים - מנהלת הסיעוד חטיבת מיילדות גניקולוגיה מחלקות: - ילודים - יולדות - חדר לידה - נשים		
אישור אחראית תחום סיעודי: מיכל קרנצלר מנהלת הסיעוד נשים ויולדות על החתום: מיכל קרנצלר		

רשימת עדכונים:

מהדורה	מהות העדכון	שם המעדכן ותפקיד	תאריך

מילות מפתח (KEY WORDS):

לידה טבעית, לידה פיזיולוגית



מב'ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

1. רקע:

1.1. לידה טבעית הינה לידה ללא משככי כאבים וללא התערבויות רפואיות. זהו "מסלול" המיועד לנשים בריאות, שמהלך הריון תקין והצפי ממעקב ההריון הוא לעובר תקין. מסלול זה מותנה בליווי צמוד של מיילדת, המאפשרת ליוולדת את הליווי הנחוץ כדי להצליח בתהליך.

2. מטרת הנוהל:

2.1. לתאר ולהגדיר את תהליך קבלת היולדת והטיפול בה עפ"י סטנדרטים אחידים, כשהיא מביעה רצונה ללדת במסלול ללידה טבעית.

3. הגדרות ומונחים:

3.1. לידה נורמלית: לידה שמתחילה באופן עצמוני, אשר מוגדרת בסיכון נמוך מתחילתה ועד סופה. הילוד נולד באופן עצמוני בין השבועות 37-42, במצג ראש. לאחר הלידה האם והתינוק במצב טוב. בלידה נורמאלית חייבת להיות סיבה מוצדקת להתערבות בלידה (WHO, 1996)

3.2. לידה טבעית:

הינה לידה פיזיולוגית (נורמאלית- ראה לעיל), אקטיבית, בה האישה בוחרת להתמודד עם צירי לידה באמצעות טיפול ותמיכה רציפים של מיילדת, תוך שימוש בשיטות לא תרופתיות הכוללות תנועתיות, עיסוי, טכניקות נשימה והרפיה, שימוש במים, דמיון מודרך וכד' (WHO 1996).

3.3. טיפול מיילדותי "אחת לאחת" (one-to-one care)

טיפול רציף על ידי מיילדת מרגע כניסתה של היולדת לשלב פעיל של הלידה. הטיפול ניתן ע"י מיילדת הבקיה בשיטות לא תרופתיות לטיפול בכאב. (Cochrane 2013 Hodnett et al)

3.4. אוכלוסיית היעד: יולדות המעוניינות ב"מסלול" לידה טבעית, שאינן מוגדרות כיולדות בסיכון, על פי קריטריונים שנקבעו מראש.

3.5. מטרת המסלול ללידה טבעית: תמיכה וסיוע ליוולדת ומשפחתה, ליצור חוויית לידה אופטימאלית עבור יולדת המעוניינת בלידה כזו. מתן השירות יעשה תוך עמידה בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הבריאות, תוך שמירה על בטיחות מרבית של היולדת ושל הילוד.



נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

4. סמכות ואחריות;

הגורם	הגדרת תחומי האחריות/סמכות
4.1 המיילדות העובדות במיון חדר לידה בתיאום עם אחראיות צוות לידה טבעית ואחראית המשמרת	מיון ואיתור יולדת ללידה פיזיולוגית
4.2 הרופא האחראי בחדר לידה	הסמכות לאשר יולדות ללידה פיזיולוגית
4.3 מיילדות שנבחרו לצוות הלידה הטבעית.	הסמכות לנהל לידה ביולדת פיזיולוגית
4.4 הרופא האחראי ו/או המיילדת המטפלת ו/או אחראית המשמרת בהתאם לשיקולים מקצועיים או לבקשת היולדת.	הסמכות להחליט להפסיק את "תהליך הלידה הפיזיולוגית"
4.5 האחיות האחראיות של חדר לידה.	הסמכות למתן אישור למיילדת להיות חלק מצוות המיילדות במסלול ללידה פיזיולוגית
4.6 מיילדת שקיבלה אישור לעבוד במסלול זה.	האחריות לטיפול ביולדת במסלול לידה טבעית
4.7 המיילדת המטפלת ביולדת	האחריות לדווח ליולדת, לצוות הרפואי ולאחראית המשמרת אודות חריגה מהתקדמות המוגדרת כתקינה, ניטור עוברי לא תקין ו/או הופעת סימנים חיוניים לא תקינים או כל ממצא חריג אחר
4.8 המיילדת והצוות הרפואי/ מיילדותי	האחריות לטפל במצבים חריגים

5. שיטת הביצוע/הנחיות:

- 5.1 ניהול המסלול ללידה טבעית כפוף לאחות האחראית בחדר לידה, וזאת בהיבטים המקצועיים, הניהוליים והתפעוליים. מיילדת בעלת כישורים בתחום ניהול לידה טבעית תמונה לעמוד בראש צוות המיילדות שיעסקו בתחום, והיא תסייע לאחות האחראית בתפעול וניהול המסלול.
- 5.2 נהלי המסלול ללידה טבעית מחייבים אישור מנהל חדר לידה, אחות אחראית חדר לידה ומנהל האגף.
- 5.3 פיקוח ובקרה על הסטנדרטים המקצועיים הם באחריות אחות אחראית חדר לידה ומנהלת הסיעוד באגף המיילדות.



מב'ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

5.4 במסלול ללידה פיזיולוגית יעבדו מיילדות בעלות ותק של 3 שנים לפחות שמעוניינות ללוות יולדות אלו, ושקבלו לכך אישור מהאחות האחראית בחדר לידה.

5.5 יש לשאוף שאותה מיילדת תמשיך ללוות את היולדת אם היא מועברת למסלול רגיל בחדר לידה.

5.6 קריטריונים לבחירת מיילדות לליווי יולדות בתוכנית ללידה טבעית:

- מיילדת שמעוניינת להיות שותפה בליווי יולדות בלידה טבעית
- ניסיון של 3 שנים ומעלה כמיילדת
- בעלת תפיסת עולם שמתאימה ללוות יולדות במסלול זה.
- עברה קורס ללידה טבעית ו/או שיש בידה כלים לתמוך ביולדות אלו (ניסיון בטיפול הוליסטי, ובעלת תפיסת עולם מתאימה).
- מסוגלת לנהל לידה באופן עצמוני.
- עברה הכשרה לתוכנית זו
- באופן חריג מומלצת ע"י האחיות האחראית בחדר לידה (גם במקרים בהם לא עמדה בכל הקריטריונים).
- חידוש האישור מידי שנה.

5.7 נושאים שיש להקפיד עליהם בהכשרת המיילדות:

- הכרות מעמיקה עם נושא הניטור העוברי התינוד, וניהול סיכונים
- קורסי BLS ו NRP בתוקף
- תנחות להריון וללידה, שיטות של רפואה משלימה רלוונטיות
- אומדן ילוד, טיפול בילוד ועידוד להנקה ו/או שימוש במגע עור לעור

5.8 הנחיות:

1. תהליכי מיון ליולדת המעוניינת לבחור במסלול של לידה פיזיולוגית.
2. עקרונות הטיפול והליווי של יולדת במסלול ללידה פיזיולוגית



נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

3. טיפול וניטור ביולדת ובעובר בשלבי הלידה השונים.

4. טיפול לאחר הלידה בילוד

5. סיבוכים במהלך ואחרי הלידה של היולדת והעובר/ילוד.

6. שחרור מחדר לידה

תהליכי מיון ליולדת המעוניינת לבחור במסלול של לידה פיזיולוגית

הקריטריונים להתאמת יולדת למסלול ללידה פיזיולוגית:

- יולדת בריאה המעוניינת ללדת במסלול ללידה פיזיולוגית
- הריון בשבועות 37 - 41
- עובר יחיד
- מצג ראש
- היולדת ביצעה מעקב הריון רציף
- היולדת חתמה על טופס הסכמה מדעת ללידה טבעית (נספח מספר 4)

התוויות נגד ללידה פיזיולוגית:

יולדת אשר לה אחד או יותר מהקריטריונים המופיעים בנספח מספר 1- התוויות נגד לניהול לידה טבעית.

מומלץ להחליט ולהיפגש עם הצוות לפני תחילת תהליך הלידה. התאמתה של האישה למסלול ללידה פיזיולוגית תבחן פעמיים:

1. המפגש הראשוני- במהלך החודש האחרון להריון באופן יזום.
 2. מפגש שני- בבואה של האישה ללדת, תיבדק ותיבחן שוב התאמתה לפי הקריטריונים. במידה ויולדת שלא עברה מפגש ראשוני, תהיה מעוניינת במסלול זה, ותתאים לפי הקריטריונים - תוכל גם היא להיכנס למסלול.
- במידה ובמהלך הלידה תחול חריגה מהתהליך הפיזיולוגי עבור האישה ו/או העובר, תועבר היולדת לטיפול שגרתי בחדר לידה תוך יידוע הצוות הרפואי.



רמב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

המפגש הראשוני: הכרות מוקדמת ובחינת ההתאמה למסלול לידה טבעית יבוצע בשליש האחרון להריון ע"י מיילדת ורופא בחדר לידה. המפגש יכלול גם אפשרות לכתיבת תוכנית לידה והסבר מפורט על המסלול. היולדת תחתום על טופס הסכמה מדעת (נספח מס' 4).

הכנת היולדת להצטרפות למסלול ללידה טבעית: יולדת שפונה לחדר לידה בבקשה להצטרף למסלול ללידה טבעית תגיע להערכה ראשונית במהלך טרימסטר שלישי (שבוע 34-6). במפגש יוסבר על התוכנית ותבוצע אנמנזה מקיפה על מנת לאמוד את התאמתה לתוכנית. כמו כן יתקיים סיור בחדר לידה ובמחלקות יולדות ותינוקיה. מומלץ שנשים שמשותפות בתוכנית יעברו קורס הכנה ללידה.

באחריות מיילדת מצוות התוכנית ורופא בכיר שימונה לכך.

בדיקה שנייה (אופציונאלי): בשבועות 37-38 האישה תגיע באופן יזום למפגש הערכה נוסף. תתקיים שיחה ויבוצע תיאום ציפיות בינה לבין נציגת התוכנית. תיבדק (כולל מוניטור, אולטרא סאונד ובדיקת רופא) ותבוצע הערכה מחודשת. תקבל הנחיות לשוב ויוסברו סימני לידה פעילה.

- ראוי שהאישה תכיר מילדות ששייכות לתוכנית, על מנת להגדיל את סיכוייה ללדת עם דמות מוכרת.

מעקב וטיפול

טיפול וניטור היולדת והעובר בשלבי הלידה השונים – חדר קבלה:

בדיקת היולדת ע"י מיילדת עפ"י נהלי חדר לידה.
עם קבלת היולדת ללידה יבוצעו: ניטור עוברי 20-30 דקות

- קבלה כמקובל ביולדות במסלול הרגיל
- תינתן הסכמת היולדת בכתב להצטרפות למסלול.

שלבי לידה

שלב I של הלידה:

היולדת תתקבל ללידה בשלב הפעיל עם צירים סדירים ו/או ירידת מים.
האזנה לדופק עוברי:

- יתבצע כל 30 דקות, במשך דקה שלמה לאחר ציר ויתועד ברשומה הרפואית של היולדת.

**רמב"ם****הקרית הרפואית לבריאות האדם**

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

- במידה ויש ספק לגבי תקינות הדופק העוברי יש לבצע ניטור רציף למשך 20 דקות לפחות (ניתן להשתמש במוניטור האלחוטי).
 - בדיקה וגנילית תעשה על פי שיקול דעת המיילדת תוך שיתוף והסכמת היולדת.
 - פקיעת קרומים:
- תעשה על פי שיקול דעת המיילדת תוך התחשבות ברצון היולדת. בכל מקרה יש לבצע בדיקה לאחר ירידת מים ספונטנית.
- לאחר פקיעת הקרומים, ספונטנית או יזומה, יש לבצע ניטור עוברי במשך דקה ולתעד הן את פקיעת הקרומים והן את הניטור העוברי.
- במידה והמים מקוניאליים יש לעבור לניטור רציף של דופק העובר.
- סימנים חיוניים: יש למדוד ולתעד סימנים חיוניים ואומדן כאב עפ"י ניהל הטיפול בכאב.
 - עירוי ובדיקות דם: יותקן לכל יולדת לאחר קבלת הסכמה ממנה. במידה ולא מסכימה יתועד הדבר בגיליון.
 - תמיכת המיילדת ביולדת באמצעות שיטות להרגעה ולהרפיה- תנועתיות כולל שימוש בכדור פיזיו, שימוש בשמנים, מוזיקה, עיסויים, שימוש במים, נשימות, דמיון מודרך, דיקור סיני, רפלקסולוגיה.
 - יש לאפשר ליולדת לשתות ולאכול עד לפתיחה של 4 ס"מ ואחרי כן ניתן לאפשר לשתות בחופשיות, סוכריה וקרטיב.
 - יש ליצור אווירה נינוחה, רגועה ואינטימית ע"י עמעום אורות, האזנה למוסיקה, שמירה על פרטיות ועידוד זוגיות, הכל לפי העדפות היולדת.
 - יש להציע ליולדת להימנע משכיבה במיטה, לעודד תנועתיות, שימוש במקלחת או אמבטיה ושינויי תנוחה. בן הזוג/המלווה יודרך על דרכים בהן יוכל לסייע ליולדת כגון נשימות, תנועתיות, טיפול במים, עיסוי.
- בדיקה לדנית תבוצע לפי שיקול דעת או בתנאים הבאים:
- בעת קבלת היולדת.
 - לאחר פקיעה עצמונית של מי שפיר.



נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

- עם הופעת תחושת לחץ.
- בהופעת שינויים בניטור עוברי.

שלב II של הלידה:

ניטור עוברי רציף או האזנה לדופק לב העובר, כל 15 דקות מיד לאחר ציר, למשך דקה, ולתעד ברשומה, במידה ובהאזנה יש ספק לגבי תקינות דופק לב העובר, יש לחבר את היולדת למוניטור למשך 20 דקות.

- יש לעודד את היולדת ללחוץ בפתיחה גמורה רק כאשר חשה בצירי לחץ.
- יש להציע ליולדת תנוחות שונות כגון: ישיבה, עמידה, כריעה ו/או שכיבה על הצד. הלידה תתבצע בכל תנוחה בה הלחץ יעיל והתנוחה נוחה ליולדת.
- יש לשמור על שלמות אזור החיץ ולבצע חיתוך לפי הצורך ולפי שיקול דעת המיילדת.

שלב III של הלידה:

- ניתן להמתין עם חיתוך חבל הטבור עד להפסקת הפעימות תוך הימנעות מהבדלי גובה בין הילוד והשליה.
- עידוד הנקה ושהיית התינוק בחיק הוריו. מומלץ להמליץ על ביצוע מגע עור לעור בין אם לילוד.
- תפירת קרע ו/או אפיזיוטומיה ע"י רופא כמקובל.
- שמירה על חום גופו של הילוד ובטיחותו עפ"י נהלי מחלקת תינוקות.
- מתן מכווצים בהזרקה תוך שרירית או תוך ורידית לפי מדיניות חדר לידה בתיאום עם היולדת.
- טיפול, השגחה והדרכת היולדת במהלך שעותיים לאחר לידה לאחר לידה על פי נוהל משרד הבריאות - חוזר מספר 41/87
- היולדת תיבדק ע"י מיילדת ורופא לפני העברתה למחלקת יולדות.
- סיכום הלידה יעשה ע"י המיילדת כמקובל.
- שחרור היולדת למחלקת יולדות יעשה ע"י מיילדת.
- הילוד ייבדק ע"י רופא ילדים כמקובל.

טיפול והשגחה על הילוד:

- אומדן ומעקב יעשה עפ"י קריטריונים כמפורט בגיליון תינוק, הטיפול בילוד יתועד בתיק רפואי ממוחשב כמקובל.



מב'ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

- מעקב וטיפול בתופעות לוואי/סיבוכים במהלך הלידה ו/או לאחריה של היולדת והעובר.
- ניהול הלידה יעשה תוך אומדן ותייעוד של מצב היולדת והעובר ובהמשך בילוד.
- יולדת אשר לה אחד או יותר מהקריטריונים המופעים בנספח מס' 2 תנוהל עפ"י החלטה רפואית.

שחרור מחדר לידה:

- היולדת והילוד ישוחררו למחלקת יולדות וילודים לאחר שעתיים.
- יולדת העוברת למחלקת יולדות, תקבל הדרכה ע"י המיילדת לגבי סימנים החורגים מהנורמה הדורשים פניה לאחות.
- במחלקת יולדות תקבל היולדת סיוע סיעודי ורפואי כמקובל ובהתאם לצורך.
- יולדת העוברת למחלקת יולדות וילוד העובר למחלקת תינוקות יבדקו עפ"י הנהלים המקובלים במחלקה.
- 5.9 הכשרת הצוות :
- 5.9.1 כל מיילדת שמשותפת בתוכנית של לידה טבעית תקבל אישור מהמיילדת האחראית לאחר שתעבור הכשרה מחלקתית או הכשרה מקצועית אחרת בתיאום עם האחות האחראית. כל מיילדת תקרא ותחתום על קריאה והבנת הנוהל.
- 5.9.2 בקרה :
- 5.9.2.1 מיילדת/אחות אחראית חדר לידה ו/או מפקחת אגף מיילדות תוודא כי המיילדות מבצעות לידה פיזיולוגית לפי הנחיות נוהל לידה טבעית עומדות בקריטריונים ובהכשרה כמוגדר בנוהל.
- 5.9.2.2 אחות אחראית/מנהלת הסיעוד באגף תבצע בקרה תקופתית ותוודא כי התייעוד ברשומה רפואית וסעודית ללידה פיזיולוגית מתבצע על פי הנחיות הנוהל.

6. דיווח ותייעוד;

- 6.1 המיילדת תתעד את מהלך הלידה בכל שלביה ברשומה רפואית וסעודית הממוחשבת או גיליון של היולדת לרבות סימנים חיוניים שנלקחו במהלך הלידה, אומדנים שבוצעו ליולדת, קרי: אומדני כאב, מעקב וניטור היולדת במהלך הלידה ואופן התקדמות הלידה, הדרכות שניתנו ליולדת וטיפולם לשיכוך כאב שבוצעו.
- 6.2 המיילדת/אחות תתעד את מצב היילוד לרבות הניטור, האומדנים והטיפולים הראשונים שבוצעו ליילוד בשעותיו הראשונות, מתן החיסונים, בדיקת המיילדת/אחות והתחלת הנקה. במידה וההורים מסרבים למתן חיסונים ליילוד או מתנגדים לכל קבלת טיפול, יש לתעד זאת במקומות המתאימים

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

7. מסמכים ישימים (סימוכין):

(יש לצרף לכל סימוכין לינק לפורטל המוסדי או לכתובת אינטרנט חיצונית):

1. ACOG(2009) ACOG Practice Bulletin No. 106: Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring: Nomenclature, Interpretation, and General Management Principles. http://obgyn.med.sc.edu/documents/antepartum_fetal_2.pdf
2. World Health Organization (1996) Care in normal birth. Geneva: WHO
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63167/1/WHO_FRH_MSM_96.24.pdf
3. Department of Health (2007) Maternity matters: choice, access and continuity of care in a safe service., London: DH
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130103035958/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_074199.pdf
4. Department of Health (2010) Midwifery 2020: Delivering Expectations, London: DH
5. Enkin M, Keirse M, Renfrew M, et al. (2000) A Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth. Oxford: Oxford University Press
6. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, et al. (2011) Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews* Issue 2. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
http://www.cochrane.org/CD003766/PREG_continuous-support-women-during-childbirth
7. International Confederation of Midwives Essential competencies for basic midwifery practice 2010 Revised 2013
<http://internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/ICM%20Essential%20Competencies%20for%20Basic%20Midwifery%20Practice%202010,%20revised%202013.pdf>

8. ארגון המיילדות בישראל: לידה טבעית: טיפול ותמיכה - נייר עמדה. מאי 2015

נדלה מתוך אתר ארגון המיילדות בישראל 16.8.2017

<http://www.midwivesil.co.il/?CategoryID=190&ArticleID=499>

9. עמדת ארגון המיילדות בישראל לגבי ניתוק מושהה של חבל הטבור בילודים במועד, יולי 2015, נדלה מתוך אתר ארגון המיילדות בישראל 16.8.2017

<http://www.midwivesil.co.il/?CategoryID=190&ArticleID=498>



רמב"ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

10. חוזר מינהל רפואה מיום 13.11.2012 הנחיות להפעלת חדרי לידה.

https://www.health.gov.il/hozer/mr31_2012.pdf

11. חוזר מינהל רפואה מס' 15/2017 : לידה טבעית (Natural childbirth) בבתי"ח והנספח

הנכלל בו לניהול מהלך הלידה הטבעית עיקרי המלצות המועצה הלאומית למיילדות וגניקולוגיה.

https://www.health.gov.il/hozer/mr15_2017.pdf

12. נוהל סיעודי רפואי מביה"ח רמב"ם : הדרכת יולדת להנקה, 1.8.2017

13. חוק זכויות החולה התשנ"ו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94

נספחים:

8.



נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

נספח 1

התוויות נגד לידה לניהול לידה טבעית

קריטריונים אימהיים:

- ניתוח רחמי קודם (קיסרי, הוצאת שריר)
- כל מחלה פנימית או כירורגית פעילה.
- היסטוריה של פקקת ורידים, DVT, תסחיף ריאתי, מום לב.
- אנמיה בשליש השלישי של ההיריון – יש לשקול לפי מצבה של היולדת
- נשים עם היסטוריה של שימוש באלכוהול/סמים.
- רעלת הריון.
- שלית פתח מרכזית, חלקית.
- היפרדות שליה.
- זיהום פעיל.
- מחלת חום.
- סוכרת הריונית. (GDM על דיאטה- ניתן לאפשר)
- מיעוט מי שפיר- לשקול
- גיל הריון מעל 42 שבועות.
- הרפס גניטלי פעיל.
- אחר, לפי שיקול דעת מקצועי

קריטריונים עובריים:

- חשד לפיגור בצמיחת העובר ו/או הערכת משקל מתחת ל 2.5 ק"ג במועד
- עובר המוערך מעל 4 ק"ג.
- מום עוברי ידוע היכול להשפיע על חיוניות העובר.
- ריבוי מי שפיר המונע התבססות של ראש העובר באגן.



רמב"ם

הקריה הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

נספח מס' 2

התוויות לשינוי גישת ניהול לידה טבעית

כל שינוי מלידה טבעית ללידה לא- פיזיולוגית יכול להתקיים בכל אחד משלבי הלידה עפ"י מצב היולדת העובר ו/או החלטת הצוות המטפל.

א. במהלך הלידה:

- רצון היולדת במשככי כאבים או אפידורל.
- מצג/מנח פתולוגי.
- דימום טרי בכמות רבה מהרגיל.
- שינויים בקצב לב העובר: קו בסיסי פחות מ 105 פעימות בדקה או יותר מ 160 פעימות בדקה - ו/או האטות משמעותיות.
- חוסר התקדמות בשלב I של הלידה.
- חום אימהי מעל 38 מעלות צלזיוס.
- ירידה בלחץ דם.
- עליה בלחץ דם.
- מים מקוניאליים.
- חשד להיפרדות שליה.
- חשד לקרע של הרחם.
- שלב II מוארך.
- שלב III מוארך מעל שעה בתנאי שאין דימום חריג

ב. לאחר הלידה:

- דימום חריג.
- שליה לא שלמה/ חשודה.
- ירידה בלחץ דם.
- קרע מדמם.
- קרע דרגה IV-III.
- שטף דם באזור חיץ הנקבים



רמב"ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

נספח מס' 3

חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996

פרק ד': הסכמה מדעת לטיפול רפואי-סעיף 13,14

1. לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך הטיפול הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה.

לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לעניין זה, "מידע רפואי", לרבות -

- א. האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל; תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע;
- ב. הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות; סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי; עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.
- ג. המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.
- ד. על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסוים למטופל, הנוגע למצבו הרפואי, אם אישרה ועדת אתיקה כי מסירתו עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל



מב'ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

נספח מס' 4

טופס בקשה והסכמה ללידה טבעית

הלידה הטבעית מיועדת ליולדות בריאות שהינן בסיכון נמוך על פי הגדרה רפואית, המבקשות ללדת בלידה טבעית ללא התערבויות רפואיות.

הלידה הטבעית מלווה ע"י מיילדת לאחר הערכת רופא.

בלידה הטבעית מנוטר דופק העובר לסירוגין בהתאם לפרוטוקול. הוסבר לי שמעקב אחרי דופק העובר אינו רציף ועלול לגרום לאיחור בזיהוי מצוקה עוברית. כמו כן הובהר לי כי בלידה טבעית עלולים להתרחש סיכונים וסיבוכים כבכל לידה. הוסבר לי כי ייתכן שבמהלך הלידה ו/או לאחריה יחול שינוי במצבי או במצבו של העובר/ילוד, או כי המשך הלידה לא יוכל להתנהל במסגרת "לידה טבעית" ויהיה עלי לקבל את הטיפול וההשגחה הנובעים מהמצב החדש שנוצר לרבות: שכיבה במיטה, חיבור רצוף למוניטור, הרכבת עירוי נוזלים וכל

התערבות רפואית אחרת שתידרש.

הוסבר לי שהחלטה על שינוי בהתנהלות הלידה הינה החלטת הצוות המטפל אשר ידאג להעברתי לחדר לידה רגיל ו/או לחדר ניתוח בהתאם למצבי הרפואי ו/או מצב העובר וכי עלי להישמע במקרה זה להחלטתו על העברתי/העברת הילוד.

אני מצהירה ומאשרת שהוסברו לי תהליכי הלידה הטבעית והסיכונים הכרוכים בה ע"י מיילדת או רופא מטפל.

חתימה וחותמת

תפקיד

שם ושם משפחה

ואני מבקשת בזאת ללדת ב"לידה טבעית" במסגרת ביה"ח.

חתימת היולדת

ת.ז.

שם היולדת

שעה

תאריך

נוהל מס':	
שם הנוהל: לידה פיזיולוגית	
JCI CODE	

נספח מס' 5

התוויות להעברת ילוד מידית למחלקת ילודים

1. נשימה:

- א. מס' נשימות מעל 60 לדקה.
- ב. רתיעות בית חזה.
- ג. נשימות תוך שימוש בכנפי אף ואנחות.
- ד. אפניאות.

2. דופק:

- א. ברדיקרדיה נמוך מ100
- ב. טכיקרדיה דופק מעל 200 בשינה או בתינוק רגוע
- ג. דופק לא סדיר.

3. צבע:

- א. כיחלון (לא MASK FACE)
- ב. חיוורון.
- ג. צבע כחול אפור שמשתפר עם מתן חמצן ומתחדש לאחר הפסקתו.
- ד. אודם משמעותי

4. חום גוף:

מתחת ל 35.5 בשתי מדידות בהפרשת של 10 דקות או מתחת ל 36 מעבר לגיל חצי שעה.

5. אפגר:

- א. 7 או פחות לאחר דקה 5
- ב. 8 או פחות לאחר דקה 10

6. רעד:

פרכוסים, תנועות לא רגילות.

7. סימני טראומה:

ERB'S שטפי דם תת עוריים, גפה שמוטה, חשד לשבר וכו'

8. מום מולד משמעותי:

חיך שסוע, חסר כזה או אחר בשלמות איברים